免疫问题

（2）血小板（首选），大剂量糖皮质激素，丙种免疫球蛋白，促血小板生成药（rhTPO、艾/海曲泊帕、罗米/普司亭），长春碱（免疫抑制剂起效慢、不单独用），切脾（纯皮板板击球）

促进血小板生成,从骨髓中释放

肾病综合征、急进性肾炎:环磷酰胺
炎症性肠病:硫唑嘌呤、巯嘌呤

2.一线治疗（击球）

急症、一线治疗:激素、丙球
急症、二线治疗:切脾、促血小板生成药(rhTPO/艾曲泊帕/罗米司亭)

（1）糖皮质激素（首选）

①机制：抑制单核-巨噬细胞系统对血小板破坏（主要）、减少自身抗体生成、改善毛细血管通透性、刺激骨髓造血及血小板向外周血释放 减少酸雨降临

不再容易出血

②在血小板上升之前患者出血症状即可改善

③糖皮质激素起效后尽快减量、6-8 周内停用（VS 肾病综合征）起始足量(8-12周),缓慢减量,长期维持(半年)

④糖皮质激素停药后易复发、但复发时仍有效

（2）丙种免疫球蛋白：妊娠可用丙球、不适合激素（怀了个球）

ITP
↓
li TPO 切脾

成熟B淋巴细胞标志:CD20

3.二线治疗：①切脾；②促血小板生成药（rhTPO、艾/海曲泊帕、罗米/普司亭小艾米）；③抗 CD20 单克隆抗体（利妥昔单抗）板栗皮 B细胞变成浆细胞产生抗体攻击RBC(温抗体自免溶)/Plt(ITP)/RBC和Plt(Evans综合征)

IgA沉积在肾小球-过敏性紫癜肾炎:①以周为单位的前驱感染②继发性肾小球疾病有自己的特点-四肢对称分布的紫癜

VS IgA肾病:①以天为单位的前驱感染
②原发性肾小球疾病

二、出血性疾病概述

（一）分类

ITP不强调紫癜是否对称

①血管壁异常：过敏性紫癜（四肢对称分布）免疫复合物IgA沉积在血管壁→IgA相关血管炎

造血衰竭 肿瘤抑制

②血小板数量减少：再障和白血病（生成减少）、ITP（破坏过多）、DIC（消耗过度）、脾亢（分布异常）

三心二意聚精无力　巨大才能做!　毒素包裹

③血小板质量异常：血小板无力症（缺乏 GPIIb/IIIa）、ttsx 巨大血小板综合征（缺乏 GPIb）、尿毒症、感染

④凝血异常：血友病（遗传缺乏凝血因子 8/9/11）、肝硬化（凝血因子合成减少）、尿毒症、维生素 K 缺乏症

尿毒症(血小板功能下调)
ITP(血小板数量↓)

学吧友友们一起出血　儿妻就是家

⑤抗凝异常

⑥纤溶异常

维持8因子稳定性

⑦复合性止血机制异常：DIC（过度消耗血小板和凝血因子+继发纤溶）、血管性血友病（缺乏 vWF）Plt粘附桥梁

	(出血时间)BT Plt、血管壁	APTT	PT
血管性血友病	延长 缺乏vWF	延长 影响VIIIC因子	正常
血友病	正常	延长 影响VIIIC因子	正常

出血倾向的主要机制：肝硬化-凝血因子合成减少、肾衰-毒素蓄积致血小板功能减低、ITP-血小板数量减少

（二）血管、凝血、抗凝、纤溶检测

既反应血管,也反应抗凝

血管检测	出血时间 BT、束臂/毛细血管脆性试验 CRT、内皮素 ET、凝血酶/血栓调节蛋白 TM、血管性血友病因子 vWF（BF etc）来自血管内皮C释放
凝血检测	①共有途径异常（10、5、2、1）：APTT、PT、TT（1）延长 ②内源性途径异常（8、9、11、12）：APTT 延长（凝血活酶生成障碍），PT 正常 ③外源性途径异常（7）：PT 延长，APTT 正常 在做凝血检测时外源性会加入3因子 注意：活化部分凝血活酶时间 APTT、凝血酶原时间 PT、凝血酶时间 TT、纤维蛋白原 Fbg
抗凝检测	AT、TAT（凝血酶-抗凝血酶复合物）、PC、PS、TM、FVIII抗体、狼疮抗凝物、心磷脂抗体　蛋白质C系统　影响凝血因子吸附
纤溶检测	鱼精蛋白副凝 3P 试验、FDP、D-二聚体、纤溶酶原、t-PA（激活物）、PAI（抑制物）、PIC（复合物）二弟放 3 个 P　12月了,突击

PT延长:7、10、5、2、1
APTT延长:12、11、9、8、10、5、2、1
TT延长:1